

Programme **AZURE BREATH**

**ADAPTATION Nx-A
SUJETS RESPIRANTS DANS LE GAZ**

Rédacteur : Dr Koskov

Niveau de classification :
CONFIDENTIEL – ORION / NIVEAU 4

// DOCUMENT CLASSIFIÉ — USAGE INTERNE ORION

PROGRAMME D'ADAPTATION Nx-A — SUJETS RESPIRANTS DANS LE GAZ

NOM DU PROGRAMME	Programme AZURE BREATH
ORGANISATION RESPONSABLE	ORION
TYPE	Expérimentation biologique militaire classifiée
STATUT	En fonctionnement

1. PRINCIPE GÉNÉRAL

Certains sujets exposés au Nx-A dans des conditions contrôlées ont développé une adaptation biologique extrême. Leur organisme ne neutralise pas totalement le gaz, mais apprend à l'utiliser comme élément respiratoire secondaire.

Le Nx-A devient alors indispensable à leur métabolisme.

En conséquence :

- ▶ Ils peuvent respirer dans les zones contaminées.
- ▶ Ils restent sensibles aux fortes concentrations.
- ▶ Ils ne sont pas immunisés face au gaz.
- ▶ Ils ne peuvent plus respirer correctement dans l'air pur.
- ▶ Une atmosphère sans Nx-A provoque un rejet respiratoire grave.
- ▶ Leur état doit être maintenu par des protocoles réguliers d'ORION.

2. JUSTIFICATION BIOLOGIQUE

À la suite des expériences, les poumons des sujets ont muté à cause de l'ion instable AZ-λ contenu dans l'Azuris. Cet ion s'est fixé durablement sur les tissus pulmonaires et nerveux, créant une forme de dépendance neuro-respiratoire.

Leur système respiratoire ne fonctionne plus uniquement avec l'oxygène classique. Il a besoin d'une concentration moyenne de Nx-A pour stabiliser :

- ▶ L'activité nerveuse ;
- ▶ La respiration ;
- ▶ Le rythme cardiaque.

Sans Nx-A, le cerveau interprète l'air pur comme un environnement incomplet ou toxique.

3. EFFETS SUR LES SUJETS ADAPTÉS

Les sujets modifiés peuvent survivre dans une zone contaminée, mais leur état reste instable.

3.1 Avantages

- ▶ Respiration possible dans les zones Nx-A.
- ▶ Résistance accrue aux effets neurotoxiques légers.
- ▶ Capacité à se déplacer dans les zones basses contaminées.
- ▶ Moins de panique respiratoire en atmosphère toxique.
- ▶ Absence de trouble visuel.
- ▶ Meilleure adaptation aux environnements contaminés.

3.2 Limites

- ▶ Ils restent vulnérables aux fortes concentrations.
- ▶ Ils peuvent encore subir des troubles neurologiques.
- ▶ Une exposition trop intense peut entraîner des complications.
- ▶ Ils ne peuvent plus respirer normalement dans l'air pur.
- ▶ Ils ont besoin d'un taux minimal de Nx-A pour survivre.
- ▶ Ils doivent subir régulièrement des tests pour conserver leur adaptation.
- ▶ Sans suivi ORION, leur efficacité diminue progressivement.

4. SEUILS DE DÉPENDANCE RESPIRATOIRE

Les valeurs ci-dessous sont issues des relevés cliniques effectués sur les Sujets Azure stabilisés. Toute déviation prolongée hors de la plage 11-61 % impose une intervention immédiate.

TAUX DE Nx-A	EFFETS OBSERVÉS
0 % Nx-A	Suffocation progressive, panique respiratoire, malaise, mort.
1 – 10 % Nx-A	Respiration difficile, malaise
11 – 30 % Nx-A	Zone respirable idéale pour un sujet adapté.
31 – 60 % Nx-A	Zone supportable, mais symptômes neurologiques possibles.
61 – 80 % Nx-A	Danger élevé, surcharge neurotoxique.
81 – 100 % Nx-A	Risque de coma, convulsions ou mort.

5. SYMPTÔMES EN ATMOSPHÈRE NORMALE

Lorsqu'un sujet adapté respire de l'air non contaminé, il peut présenter :

- ▶ Toux sèche violente.
- ▶ Oppression thoracique.
- ▶ Sensation d'étouffement.
- ▶ Tremblements.
- ▶ Vertiges.
- ▶ Perte d'équilibre.
- ▶ Confusion.
- ▶ Spasmes musculaires.
- ▶ Malaise.
- ▶ Perte de connaissance.

6. SYMPTÔMES EN ZONE À FORTE CONCENTRATION EN Nx-A

Même adapté, un sujet exposé à une concentration trop élevée peut subir :

- ▶ Maux de tête intenses.
- ▶ Troubles du comportement.
- ▶ Agressivité.
- ▶ Hallucinations.
- ▶ Pertes de mémoire temporaires.
- ▶ Douleurs pulmonaires.
- ▶ Convulsions.
- ▶ Arrêt respiratoire.

7. STABILISATION OBLIGATOIRE DES SUJETS

L'adaptation au Nx-A n'est pas permanente. Les modifications provoquées par l'ion AZ-λ sont artificielles et instables. Avec le temps, l'organisme du sujet tente naturellement de revenir à un fonctionnement respiratoire normal.

Ce phénomène est appelé :

RÉGRESSION BIOLOGIQUE AZ-λ

8. PRINCIPE DE RÉGRESSION

Sans suivi expérimental régulier, le corps du sujet commence à rejeter progressivement les altérations provoquées par le programme AZURE BREATH. Les tissus pulmonaires se régénèrent partiellement, l'activité nerveuse se rééquilibre et la dépendance au **Nx-A** diminue.

Pendant la phase de régression, le sujet devient instable et perd progressivement ses capacités d'adaptation. À terme, l'organisme n'est plus capable de maintenir ses fonctions vitales sans les modifications induites par le programme, ce qui provoque une défaillance systémique et entraîne le décès du sujet.

9. CONSÉQUENCES SANS MAINTENANCE ORION

Si ORION cesse les tests, les injections ou les expositions contrôlées, le sujet subit une perte progressive d'efficacité.

Phase 1 — Instabilité légère

- ▶ Respiration plus difficile dans les zones Nx-A.
- ▶ Toux plus fréquente.
- ▶ Fatigue rapide.
- ▶ Légers vertiges.
- ▶ Baisse de la tolérance au gaz.

Phase 2 — Rejet partiel

- ▶ Douleurs thoraciques.
- ▶ Pertes d'équilibre.
- ▶ Maux de tête.
- ▶ Troubles du comportement.
- ▶ Baisse nette de la résistance au Nx-A.
- ▶ Nécessité d'une assistance respiratoire.

Phase 3 — Régression avancée

- ▶ Forte instabilité neurologique.
- ▶ Pertes de mémoire temporaires.
- ▶ Crises de panique respiratoire.
- ▶ Risque de malaise ou de coma en cas d'exposition au Nx-A.
- ▶ Hallucinations visuelles et auditives.

Phase 4 — Décès

- ▶ Décès du sujet.

10. Maintien des sujets

Maintien des sujets dans un état d'adaptation artificielle grâce à des protocoles réguliers. Ces protocoles peuvent inclure :

- ▶ Expositions contrôlées au Nx-A.
- ▶ Injections de stabilisateurs AZ-λ.
- ▶ Tests neurologiques.
- ▶ Contrôle du rythme cardiaque.
- ▶ Mesures de saturation neuro-respiratoire.
- ▶ Ajustement du taux de dépendance Nx-A.
- ▶ Analyses comportementales.
- ▶ Surveillance des pertes de mémoire.
- ▶ Évaluation de la tolérance respiratoire.

Sans ces interventions, le sujet perd progressivement sa capacité à respirer.

11. FRÉQUENCE DES TESTS

Les sujets doivent subir des tests réguliers pour conserver leur adaptation. Au minimum 1 fois par mois.

En cas de retard ou d'absence de traitement, la régression biologique peut commencer.

12. OBJECTIF DU PROGRAMME

Le programme AZURE BREATH vise à permettre la survie humaine en environnement contaminé. ORION cherche à créer des sujets capables d'opérer dans des zones Nx-A sans équipement lourd.

Ces sujets peuvent être utilisés pour :

- ▶ Reconnaissance en zone contaminée.
- ▶ Récupération de matériaux Azuris.
- ▶ Exploration de souterrains toxiques.
- ▶ Opérations militaires en environnement interdit.
- ▶ Tests de résistance neurologique.
- ▶ Étude de la dépendance au Nx-A.

13. FAIBLESSE PRINCIPALE DES SUJETS AZURE

Un Sujet Azure n'est, pour le moment, jamais définitivement adapté. Son état dépend directement du suivi ORION et de l'équilibre du Nx-A dans son organisme.

Sans maintenance, le sujet perd progressivement son efficacité et son corps commence à rejeter les altérations provoquées par le programme. Avec une dose trop élevée de Nx-A, il risque une surcharge neurotoxique. À l'inverse, sans Nx-A, il s'expose à un effondrement respiratoire.

Le sujet est donc maintenu dans un équilibre instable, coincé entre deux dangers :

- Trop peu de Nx-A : rejet respiratoire et perte progressive des adaptations.
- Trop de Nx-A : surcharge neurotoxique et dégradation du système nerveux.

L'objectif actuel du programme AZURE BREATH est de dépasser cette dépendance au suivi constant. Les recherches visent à rendre les sujets définitivement adaptés, capables de maintenir leurs altérations de manière stable sans intervention régulière d'ORION et sans risque d'effondrement physiologique.

FIN DU DOCUMENT — CONFIDENTIEL ORION / NIVEAU 4
